MATERIAIS E MÉTODOS

Fontes de dados e estratégia de busca

Formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: "o que a literatura científica apresenta sobre os modelos de encaminhamento de pacientes entre as especialidades médicas no contexto do ambulatório hospitalar?". O objetivo geral do estudo é analisar os diversos modelos expressos na literatura científica sobre o encaminhamento dos pacientes de uma especialidade médica para outra no âmbito dos serviços hospitalares que prestam assistência médica em ambulatórios. São objetivos específicos desta pesquisa: a) identificar os distintos modelos de encaminhamento entre as especialidades médicas nesse contexto de atenção à saúde; e b) analisar as características, incluindo as vantagens e as desvantagens, de cada um desses modelos.

A etapa inicial da revisão sistemática compreendeu o planejamento de uma estratégia de busca sistemática e estruturada, fundamentada na declaração 2020 dos Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) (Page *et al*., 2022). Os itens-chave 'encaminhamento', 'especialidades médicas' e 'ambulatório hospitalar' foram extraídos da pergunta de pesquisa, derivados em três descritores disponíveis nos tesauros Medical Subject Headings (MeSH) e Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), edição 2026: "Encaminhamento e Consulta", "Especialização" e "Ambulatório Hospitalar".

Combinou-se os descritores e suas variações com os operadores booleanos de oposição (OR) e de adição (AND), resultando em sintaxes de busca nos idiomas português, inglês e espanhol. As fontes de dados incluíram seis portais de busca on-line, considerando-se a densidade de publicações indexadas, a autoridade científica nas áreas pertinentes ao estudo e a extensão da cobertura territorial de suas bases de dados: a) Embase®, b) Portal da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), c) Pubmed®, d) Portal da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), e) Scopus®, e f) Web of Science®.

Após buscas exploratórias nos portais utilizando múltiplas sintaxes provisórias, optou-se pela seguinte sintaxe definitiva de busca em português: *(Encaminhamento OR "Encaminhamento Ambulatorial") AND (Especialist*) AND ("Ambulatório Hospitalar")*; com a sintaxe correspondente em inglês: *(Referral OR "Outpatient Referral") AND (Specialist*) AND ("Outpatient Clinics")*, e em espanhol: *(Derivación OR "Derivación Ambulatorial") AND (Especialist*) AND ("Servicio Ambulatorio en Hospital")*.

Utilizando-se as sintaxes definitivas nos três idiomas, a pesquisa foi realizada no dia 29 de abril de 2026 e recuperou 7.427 publicações nas bases de dados consultadas (Tabela 1). Desse total, o portal da LILACS contribuiu com 5.815 publicações, seguido por Scopus® (660), Pubmed® (411), Embase® (367), Web of Science® (173) e SciELO (1). O gerenciamento desses resultados foi realizado por meio do aplicativo on-line Rayyan®, onde as referências foram inseridas após a

exportação do arquivo resultante da busca nos portais, permitindo o agrupamento das publicações e o prosseguimento do estudo.

Tabela 1. Distribuição da quantidade de publicações recuperadas nos portais de busca, segundo o idioma e a sintaxe de pesquisa utilizada

Idioma	Sintaxe de busca	Portal de busca	Número de publicações
Português	(Encaminhamento OR "Encaminhamento Ambulatorial") AND (Especialist*) AND ("Ambulatório Hospitalar")	Embase®	0
		LILACS	1.340
		Pubmed®	0
		SciELO	1
		Scopus®	0
		Web of Science®	0
Inglês	(Referral OR "Outpatient Referral") AND (Specialist*) AND ("Outpatient Clinics")	Embase®	367
		LILACS	3.134
		Pubmed®	411
		SciELO	0
		Scopus®	660
		Web of Science®	173
Espanhol	(Derivación OR "Derivación Ambulatorial") AND (Especialist*) AND ("Servicio Ambulatorio en Hospital")	Embase®	0
		LILACS	1.341
		Pubmed®	0
		SciELO	0
		Scopus®	0
		Web of Science®	0
		Total	7.427

Identificação, seleção e inclusão dos artigos na revisão

A segunda etapa metodológica deste estudo compreendeu a identificação, seleção e inclusão das publicações, conforme detalhado no fluxograma da Figura 1. Das 7.427 publicações identificadas inicialmente nos portais de busca, 3.801 foram excluídas por duplicidade e 2.381 por estarem fora do período de análise estabelecido. As 1.245 publicações restantes foram avaliadas, resultando na exclusão de 52 registros devido ao idioma (n = 28) ou por não se configurarem como artigos (n = 24).

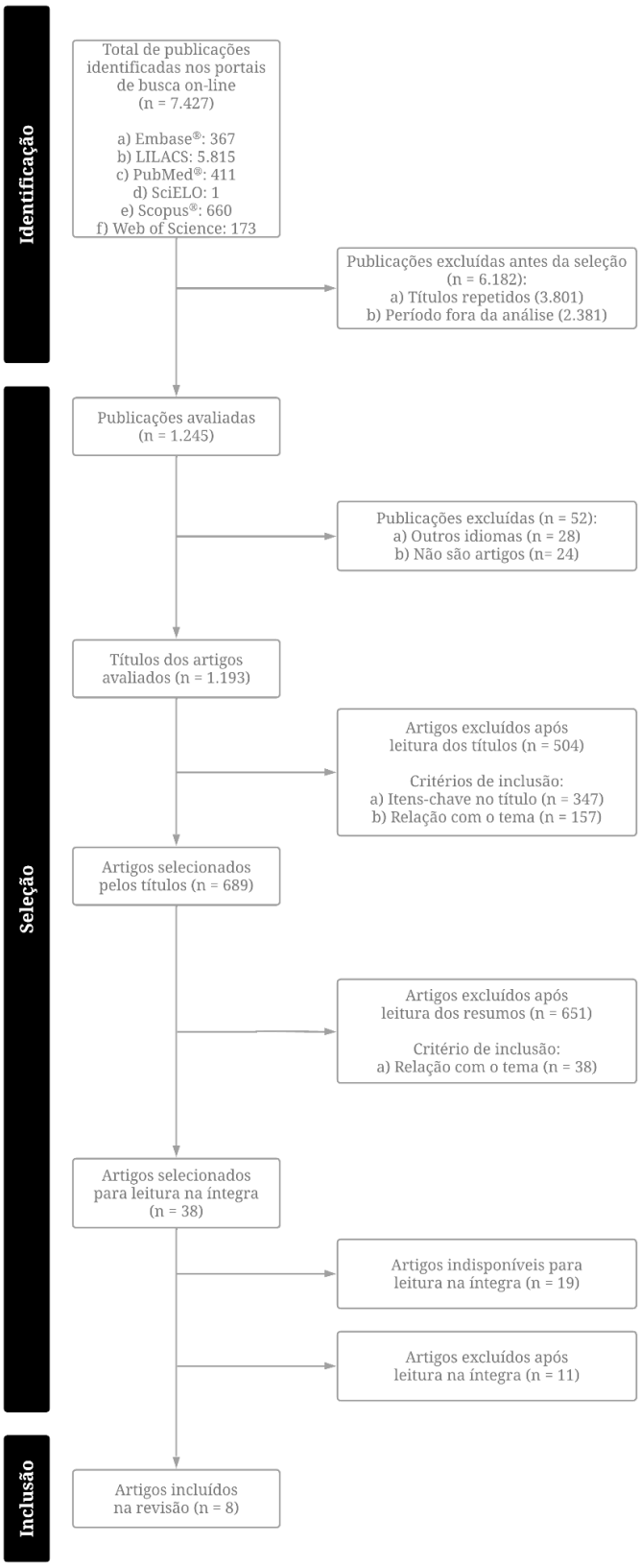
Na fase subsequente, procedeu-se à avaliação de 1.193 títulos: foram selecionados 689 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, sendo 347 pela presença de itens-chave no título e 157 pela relação direta com o tema da pesquisa. Após a leitura dos resumos, 651 artigos foram descartados, restando 38 selecionados para leitura na íntegra.

Na etapa final de análise, 19 artigos foram excluídos por estarem indisponíveis para consulta e 11 foram removidos após a leitura completa. Ao término do processo, 8 artigos foram incluídos na revisão final.

Análise e comparação dos dados

Após a leitura integral dos 8 artigos incluídos na revisão, foi elaborada uma matriz de caracterização e síntese (quadro-síntese) focada em modelos de encaminhamento e fluxo de pacientes especificamente entre médicos especialistas no contexto ambulatorial hospitalar (Quadro 1). Este quadro contempla a identificação dos estudos (autoria, revista e ano de publicação) junto à descrição detalhada do modelo de encaminhamento identificado e a análise de suas respectivas vantagens e desvantagens.

Figura 1. Fluxograma do processo de identificação, seleção e inclusão dos artigos na revisão sistemática



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-CHALABI, S. *et al*. Improving outpatient clinic experience: the future of chronic kidney disease care and associated multimorbidity. *BMJ Open Quality*, v. 12, e002188, p. 1-3, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1136/bmjoq-2022-002188. Acesso em: 4 maio 2026.

BELOSTOTSKY, V.; ROY, M.; MIKROGIANAKIS, A. Patient triage to specialist outpatient clinics-time to standardize terminology. *Paediatrics & Child Health*, v. 27, n. 5, p. 291-296, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1093/pch/pxab086. Acesso em: 4 maio 2026.

FAROUK, S. S. *et al*. Implementation of a quality improvement strategy to increase outpatient kidney transplant referrals. *BMC Nephrology*, v. 21, n. 192, p. 1-6, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12882-020-01855-0. Acesso em: 4 maio 2026.

GANDESBERY, B.; DOBBIE, K.; GORODESKI, E. Z. Outpatient Palliative Cardiology Service Embedded Within a Heart Failure Clinic: experiences With an Emerging Model of Care. *American Journal of Hospice & Palliative Medicine*, v. 35, n. 4, p. 1-5, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1177/1049909117729478. Acesso em: 4 maio 2026.

JARCZYK, K. S. *et al*. An Integrated Nurse Practitioner-Run Subspecialty Referral Program for Incontinent Children. *Journal of Pediatric Health Care*, v. 32, n. 2, p. 184-194, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2017.09.015. Acesso em: 4 maio 2026.

KLINKERT, A. F. *et al*. Integrating healthcare for follow-up of adult COVID-19 patients in an outpatient clinic: a matter of cooperation. *Health Science Reports*, v. 5, e504, p. 1-7, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1002/hsr2.504. Acesso em: 4 maio 2026.

NOVOA, N. M. *et al*. La discusión de casos por videoconferencia mejora la eficiencia de la consulta externa de cirugía torácica. *Archivos de Bronconeumología*, v. 52, n. 11, p. 549-552, 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.arbres.2016.04.002. Acesso em: 4 maio 2026.

PAGE, Matthew J. *et al* . A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. *Epidemiol. Serv. Saúde*, Brasília, v. 31, n. 2, e2022107, 2022. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s1679-49742022000200033. Acesso em: 4 maio 2026.

SAFI, M. *et al*. Today's referral is tomorrow's repeat patient: referrals to and between medical outpatient clinics in a hospital. *BMC Health Services Research*, v. 22, n. 254, p. 1-8, 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12913-022-07633-y. Acesso em: 4 maio 2026.

Quadro 1. Quadro-síntese dos modelos, vantagens e desvantagens dos artigos incluídos na revisão sistemática da literatura que descrevem ou fundamentam modelos de encaminhamento e fluxo de pacientes entre médicos especialistas no contexto ambulatorial hospitalar.

Autores	Periódico	Ano	Modelo	Vantagens	Desvantagens
Al-Chalabi *et al*.	**BMJ Open Quality**	2023	Clínica Metabólica Cardiorrenal (MRC) com dashboard de risco	Reduz a fragmentação do cuidado, otimiza a gestão farmacêutica e permite intervenções precoces em pacientes complexos	Exige infraestrutura digital robusta e alta coordenação de equipe multidisciplinar

Novoa *et al*.	**Archivos de Bronconeumología**	2016	e-Consulta via Videoconferência (discussão sistemática de casos)	Melhora a eficiência das consultas presenciais (maior índice de cirurgias por consulta), evita exames duplicados e deslocamentos	Depende de equipamentos técnicos estáveis e requer tempo dedicado dos especialistas para reuniões virtuais
Farouk *et al*.	**BMC Nephrology**	2020	Alertas automatizados no Prontuário Eletrônico (eGFR)	Modelo gratuito (se usar prontuário existente), simples e escalável, aumenta significativamente as taxas de encaminhamento para transplante	Risco de viés por observação (Efeito Hawthorne) e dependência da atenção do médico aos alertas do sistema

Safi *et al*.	**BMC Health Services Research**	2022	Gestão de Encaminhamentos Interdepartamentais e Inter-especialidades	Identifica ineficiências internas (como altas taxas de auto-encaminhamento) e incentiva a colaboração entre departamentos	Evidencia a sobrecarga administrativa e a fragmentação do cuidado quando focado em uma "única doença"
Klinkert *et al*.	**Health Science Reports**	2022	Alocação Multidisciplinar baseada em questionários de sintomas	Gestão eficaz do fluxo de pacientes, distribuição proporcional da carga de trabalho e pouca necessidade de re-encaminhamentos internos	O sucesso pode depender de colaborações prévias entre os especialistas (ex: trabalho conjunto em enfermarias)

Gandesbery, Dobbie, Gorodeski	**American Journal of Hospice & Palliative Medicine**	2017	Serviço de Especialidade "Embutido" (*Embedded*) fisicamente	Facilita a comunicação imediata e a integração clínica, aumenta as taxas de encaminhamento subjetivo por especialistas	Amostras pequenas em estudos iniciais e potencial viés de encaminhamento baseado na percepção individual do médico
Jarczyk *et al*.	**Journal of Pediatric Health Care**	2018	Ponto de Cuidado Único Integrado (*Single Point of Care*)	Quebra "silos" entre especialidades, reduz a fragmentação e apresenta alta satisfação do paciente e sustentabilidade fiscal	Ambientes de reembolso baseados apenas em "taxa por serviço" podem oferecer pouca margem operacional para o modelo

Belostotsky, Roy, Mikrogianakis	**Paediatrics & Child Health**	2022	Sistema de Triagem MASTER (Nomenclatura Padronizada)	Uniformiza a definição de urgência entre especialidades, permite análise precisa de desfechos de agendamento e aplicabilidade universal	Exige adoção institucional ampla e treinamento para alterar terminologias de triagem já enraizadas em cada departamento